

PSORIASIS

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Entre un 80 y un 90% de las personas afectadas de psoriasis pueden presentar afectación ungueal a lo largo de su vida¹. Se caracteriza por:

- Hiperqueratosis subungueal.
- Mancha oleosa o de aceite o parches asalmonados (Fig.2): decoloración amarillenta o rosada del lecho ungueal.
- Onicolisis: separación de la placa ungueal del lecho.
- Hemorragias en astilla: finas líneas rojizas o marronáceas subungueales.
- Pitting o punteado ungueal (Fig.3): pequeños hoyuelos en la lámina ungueal



Figura 2: Mancha de aceite.



Figura 3: Pitting o punteado ungueal.

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico es clínico y se establece mediante una anamnesis y una exploración física completa en busca de lesiones compatibles con psoriasis. La onicomicosis es el principal diagnóstico diferencial. Ambas patologías comparten la hiperqueratosis subungueal y onicolisis distal, siendo el pitting y la mancha oleosa más frecuentes en la psoriasis. Ante la duda, se debe tomar un cultivo de la uña.

No hay que olvidar la posibilidad de una artritis psoriásica concomitante, que ocurre hasta en el 40% de los pacientes. Se trata de una artritis seronegativa, oligoarticular asimétrica, siendo típicas la inflamación de la articulación interfalángica distal y la dactilitis.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: aplicación regular de emolientes, mantener las uñas cortas, evitar traumatismos, humedad e irritantes.
- En casos leves y sin afectación funcional, el tratamiento preferido es el tópico, siendo de primera línea los corticoides y los análogos de la vitamina D, en monoterapia o en combinación².

- Si la afectación es moderada o grave, con síntomas significativos, afectación funcional, afectación cutánea de más del 8% o síntomas articulares, el paciente deberá ser derivado al especialista para valorar el inicio de tratamiento sistémico (acitretino, inmunosupresores, inhibidores del TNF-alfa, etc.)².

BIBLIOGRAFÍA.

- Tan EST, Chong W-S, Tey HL. Nail Psoriasis: A Review. American Journal of Clinical Dermatology. diciembre de 2012;13(6):375-88.
- Crowley JJ, Weinberg JM, Wu JJ, Robertson AD, Van Voorhees AS. Treatment of Nail Psoriasis: Best Practice Recommendations From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. JAMA Dermatol. 1 de enero de 2015;151(1):87.
- Oram Y, Akkaya AD. Treatment of Nail Psoriasis: Common Concepts and New Trends. Dermatology Research and Practice. 2013;2013:1-13.
- Fitzpatrick, Goldsmith LA. Dermatología en medicina general. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2014.
- Vañó S, Jaén Olasolo P. Dermatología. Madrid: Medical & Marketing Communications; 2016.